ONEMA-POP-033 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-033 — Avaliação da Dor e Integração ao Processo de Enfermagem

1. Identificação institucional

983558 | Data: 09/11/2026.

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação da dor e integração ao processo de enfermagem na atuação da rede ONEMA ONE, com avaliação, execução segura, continuidade e escalonamento. Aplicável ao atendimento domiciliar e, quando pertinente, digital; não substitui decisões médicas nem suporte de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Execução e julgamento clínico por enfermeiro habilitado, conforme competências e treinamento. Indicações: Pacientes com dor aguda ou crônica em qualquer cenário ONEMA; não retardar avaliação de emergência. Contraindicações operacionais: ausência de consentimento ou de condições seguras, urgência incompatível com atendimento eletivo, ou ação fora da competência/prescrição.

4. Materiais, equipamentos e fornecimento

Enfermeiro: escala numérica ou verbal, instrumentos observacionais validados quando necessário, aparelhos para sinais vitais; paciente: lista de medicamentos e histórico de analgesia. Em visitas presenciais, o profissional dispõe de aparelho de pressão validado, estetoscópio, termômetro e oxímetro; utilizar conforme avaliação. Insumos específicos são providenciados pelo paciente/responsável, salvo acordo contratual.

5. Avaliação clínica e preparo

Localização, início, duração, intensidade, qualidade, irradiação, fatores de piora/alívio, função, sono, impacto emocional e sinais de alarme. Confirmar identidade, consentimento, privacidade, ambiente e plano prévio; estabelecer linha de base e reconhecer urgências antes de iniciar.

6. Execução técnica numerada

1. Identificar localização, início e circunstância da dor, incluindo trauma ou procedimento recente.

2. Aplicar escala de 0 a 10 quando possível; registrar método e capacidade de comunicação.

3. Caracterizar qualidade, irradiação, frequência, fatores desencadeantes e sintomas associados.

4. Pesquisar sinais de emergência: dor torácica, déficit neurológico, abdome agudo, isquemia de membro ou febre com instabilidade.

5. Avaliar impacto funcional e resposta a intervenções prévias, incluindo efeitos adversos dos analgésicos prescritos.

6. Formular diagnósticos e resultados de Enfermagem conforme avaliação e plano individualizado.

7. Implementar medidas não farmacológicas adequadas e administrar medicação apenas com prescrição válida e

checagens de segurança.

8. Reavaliar intensidade e função após intervenção no intervalo apropriado; comunicar ausência de resposta e registrar.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Dor súbita intensa com instabilidade, déficit focal, dor torácica ou sinais de abdome agudo: SAMU 192/serviço de urgência. Em emergência, acionar SAMU 192 e registrar horário e destinatário; não retardar atendimento por registro digital.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar reavaliação programada, uso correto de medicamentos prescritos e retorno se houver piora ou novos sinais. Confirmar compreensão por retorno verbal e definir quem será contatado em caso de piora.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa, histórico e avaliação, sinais vitais pertinentes, diagnósticos

e plano de Enfermagem, passos executados e não executados com justificativa, resposta clínica, intercorrências, orientações, contatos e encaminhamentos, profissional responsável e assinatura/trilha de auditoria.

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

 COFEN, Resolução nº 736/2024 — Processo de Enfermagem — https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/